研究方案 • 公共卫生博士

促进对居家老年人同时存在的不同社会需求和医疗照护需求的跨部门响应：人群特征类型、资源制图与网络分析。



Eric Bernier, LL.M.、M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
公共卫生博士 · 卫生系统、组织与政策 · ESPUM，蒙特利尔大学

共同导师：
Nadia Sourial 博士与 Géraldine Layani 博士

01 背景

CCSMTL：8个CLSC辖区，2026年65岁及以上人口48,575人
ISQ, 2026

≈ 3,700
70岁及以上人士向211提出的求助，2021-2026年
211 Grand Montréal，2026

691
60岁及以上未满足的需求（敏感性分析）
211 Grand Montréal，2026

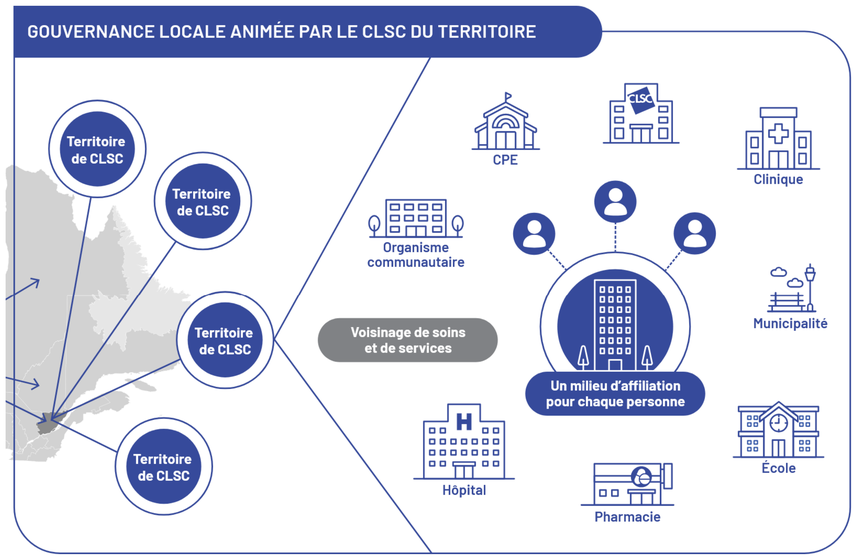
需要区分的三个概念
居家接受随访的老年人累积多种社会需求；应对在CLSC辖区内组织。

并存需求
同一个人同时存在社会需求和医疗照护需求。

居家老年人
居家老年人，同时存在社会需求和医疗照护需求，可能需要基层医疗中的跨部门响应。

在辖区内组织
跨部门应对
卫生以外的部门与卫生部门共同开展、作用于健康或其决定因素的行动：公共网络、初级卫生保健、准公共部门、社区、市政、住房。
MSSS, 2017; Leppo et al., 2013

一线服务政策 • MSSS, 2026
CLSC 辖区成为参照单位



CLSC 的四个角色
导航者 · 协调者 · 跨部门引领者 · 共同推动者

"秉持共享治理的精神" · MSSS, 2026, p. 42 · 示意图：MSSS, 2026

如何组织跨部门响应，以满足居家老年人不同特征类型同时存在的社会需求和医疗照护需求？

01
识别居家老年人的不同特征类型：这些人同时存在社会需求和医疗照护需求，可能需要在基层医疗中获得跨部门响应。

02
绘制可能在基层医疗中动员、以满足居家老年人不同特征类型同时存在的社会需求和医疗照护需求的地区资源，并描述其可用性、多样性、互补性和可及性的地区差异。

03
分析基层医疗中为满足居家老年人不同特征类型同时存在的社会需求和医疗照护需求而在地区内动员的跨部门网络的组织配置，以描述其运作方式。

02 拟议研究方法

暂定方案 • 研究地点、合作关系与授权有待确认

居家老年人，同时存在社会需求和医疗照护需求，可能需要基层医疗中的跨部门响应。

方法目标 01
开展科学文献综述，以识别和描述居家老年人的不同特征类型：这些人同时存在社会需求和医疗照护需求，可能需要在基层医疗中获得跨部门响应；并确定每种特征类型对应的需求。

范围综述 • 4个数据库

- 系统检索、明确纳入标准，由两名评审者独立筛选。
- 人群、基层医疗背景、社会与医疗照护需求、定义、测量工具、同一个体中的并存情况及已报告的特征类型。
- 依照JBI开展范围综述，按PRISMA-ScR报告；描述性综合定义、相关需求和已有证据支持的组合。

方法目标 02
对基层医疗中可动员的资源开展制图与空间研究，以回应居家老年人特征类型所对应的不同并存社会需求和医疗照护需求，并描述这些资源在不同CLSC辖区的分布、可用性、多样性、互补性和地区可及性。

6个部门 • 生态与空间分析

- 在选定来源中系统识别合格资源，明确纳入和去重规则。
- 位置、部门、需求领域、有记录的可用性、获取条件、资格、时段和已知容量。
- 在R和QGIS中开展制图与空间研究，描述分布、可用性、多样性、互补性和地区可及性。

方法目标 03
开展从多个CLSC辖区出发、在基层医疗中动员的跨部门社会网络回顾性分析，以回应居家老年人不同类型的并存社会与医疗照护需求，描述网络的组成、关系结构以及行动者之间合作的性质与强度。

单一问卷 • 12个月 • 整体与自我中心网络

- 一次性关系问卷，回顾过去12个月；辅以少量开放题，不另行开展访谈。.
- 收集各辖区界定范围内所有组织间的关系，依据覆盖程度分析组成、结构与运作。
- 以包括CLSC在内的组织或团队为中心，分析规模、多样性及ego-alter关系；alter-alter关系须专门采集。

01：类型 • 02：资源 • 03：网络。多个差异化CLSC辖区的回顾性定量观察网络研究。

03 预期产出 • 此处不展示博士研究结果

有证据支持的需求组合与情境短例

资源图集与需求-资源-地区矩阵

情境化组织网络与机制解释

04 预期贡献

认识需求、可及供给与实际动员帮助之间的差距；与相关人员及地区行动者讨论组织改进方向。不保证个人获益。

接触 ≠ 合作 ≠ 获得帮助 ≠ 需求得到解决。211数字与背景地图均为示例，不能替代O3数据收集。

Brewster, Tan, & Yuan (2019). Health Services Research, 54(6), 1246-1254. doi:10.1111/1475-6773.13206 • AHRQ (2014), Care Coordination Measures Atlas, ch. 4.